

Información Paciente

Nombre : Gisela Denis Basoalto Jorquera
Edad : 20a 5m 14d
Dirección : Pasaje N6 1130

Rut : 20.562.068-0
Fecha Nacto: 19/07/2002
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1605635
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 2032 6766

N° Epicrisis
335655

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 01/01/2023 06:35

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 02/01/2023 16:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

NOMBRE : GISELA DENIS BASOALTO JORGUERA.
EDAD : 20 AÑOS.
RUT : 20256068-0
FI HSR : 01/01/2023
FI UPC : 01/01/2023. HORA 14:05
PROCEDENCIA : URGENCIA.

ANTECEDENTES PATOLOGICOS:

- Síndrome Antifosfolipidico, con TEP hace 6 meses , se realizó trombectomia.
- TVP hace un mes.
- Anti coagulada con warfarina.
- ERC. Glomerulonefritis de complejo inmune mesangial. IgG positivo.
- Sobrepeso.
- Se niega alergias, así como otras patología.
- No tabaquismo, ni OH.

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD:

Historia no muy clara.

Ingresa en la UEA del HSR, procedente de su domicilio. Al ingreso con signos de falla respiratoria, con requerimiento de oxígeno suplementario, mala mecánica, y desaturación.

Se define protección de vía aérea, en secuencia rápida, previa sedación.

Se solicita laboratorio que informa: Covid negativo, láctico 27, bilis total 1.36, troponina I 24.3, bun 22, PCR 25.2, INR 1.98, KPTT 53, sodio 135, potasio 4.19, cloro 105.

Se conecta a VMI, e inicia DVA. Se solicita imágenes de control. se toma angiotac de torax que informa:

- Extenso tromboembolismo pulmonar de la arteria pulmonar principal izquierda así como de todas sus ramas.
- Se agrega tromboembolismo pulmonar en rama lobar inferior derecha y sus ramas segmentarias basales.
- Extensos focos de condensación multifocales de predominio derecho, de posible origen inflamatorio infeccioso.
- Presencia de infarto pulmonar en segmentos basales de LID sobreagregado no es descartable.

Fecha Epicrisis : 02/01/2023 16:01

Fecha Última Actualización: 02-01-2023 16:01:30

Página 2 de 3

- Leve derrame pleural derecho.
- Aumento del tamaño de cavidades cardíaca derechas, de predominio auricular.- Obs signos de sobrecarga.

Dado compromiso respiratorio, así como hemodinámico, edad de la paciente, es candidata a apoyo circulatorio extracorpóreo. Por tal motivo se solicita cama en UPC.

Al ingreso a la UPC.

Paciente bajo sedación y BNM, bien adaptada, caliente, clínicamente con perfusión comprometida.

- Neurológico: no valorable, por sedación. Pupilas simétricas, reactivas.
- Tórax: simétrico. Mv disminuido en forma difusa.
- Corazón: rítmico.
- Abdomen: blando depresible., sin peritonismo, algo distendido, RHA ausentes.
- Extremidades: simétricos, mal perfundido, llenado capilar mayor a 2 segundos.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

- SHOCK OBSTRUCTIVO/ INFECCIOSO. TEP + NAC.
- TEP MASIVO. SIGNOS DE SOBRECARGA DERECHA.
- OBS PROCESO INFECCIOSO AGREGADO.

Evolución en UCI:

Paciente de extrema gravedad.

Cursó Shock Cardiogénico 2ario a TEP Masivo.

Se realizó trombolisis con Alteplase sin mayor impacto clínico.

Evoluciona en Shock Refractario, Norepinefrina y Adrenalina en dosis altas,

Taquicárdica de 160 por minuto, clínicamente mal perfundida, CRT 6 segundos, fría a distal.

US bedside con evidente sobrecarga derecha, VD > VI, Signo de la D y McConell (+), TAPSE de 0.5 cm.

VMI protectora, SAS 1 con BNM, FiO2 100%.

Saturación de 85%, PaFiO2 de 55. CO2 de 77. Acidosis Severa Mixta.

Con material trombotico en VCI lo que imposibilita su conexión a ECMO V-A como terapia de rescate.

Se decidió trombolizar ayer como intento de reperfusión de VCI, sin embargo evolucionó con mayor inestabilidad hemodinámica y ventilatoria lo que hace imposible su traslado para AngioTAC de control post-trombólisis.

Dado profundización de Shock y falla respiratoria severa con importante nivel de Shunt, en una paciente no candidata a terapias de rescate y con pronóstico ominoso a corto plazo, se define que se encuentra fuera del alcance terapéutico. Jefatura UPC al tanto. Se avisa a familiares.

Paciente fallece a las 14:31 en compañía de familiares.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda -
Tromboembolismo pulmonar (TEP) - TEP Masivo
Shock cardiogenico -
Insuficiencia Respiratoria aguda -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecida

Plan Post Alta

Fallecida

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 02/01/2023 16:01

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 02-01-2023 16:01:30

Página 3 de 3

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Daniel Sánchez Sobarzo
Médico Tratante (Staff)